

## 14 - 04-Région carotidienne - Pr. DAROUASSI

Bonjour, je suis le professeur Agrégé Youssef Terwassi. Nous allons parler de la région carotidienne. La région carotidienne est située au niveau de la partie latérale du cou, en avant de la région sus-claviculaire, en arrière de la région parotidienne, de la région subondulaire et de la région sous-ihuidienne.

Elle est masquée par les muscles sternocleidomastoidiens qui constituent le couvercle de la région. Elle présente à décrire une loge ostéomusculaire et un contraire. Nous allons commencer par la loge ostéomusculaire.

C'est un quadrilatère oblique, en haut et en arrière, limité en avant par le bord antérieur du muscle sternocleidomastoidien, en arrière par le bord postérieur du muscle sternocleidomastoidien, en haut par la ligne horizontale joignant la mastoïde à la mandibule, en bas par la clavicule et la fourchette sternale. Cette loge ostéomusculaire présente trois parois, une paroi postérieure, une paroi externe et une paroi interne. Nous allons commencer par la paroi postérieure.

Elle est constituée par le rachis cervical avec les apophyses transverse de C3 à C7. Celle de C6 est saillante. Elle est appelée tubercule de Chasséniaque, qui est repère de la carotide primitive en chirurgie.

Elle présente également à décrire les muscles de la région prévertébrale et les éléments nerveux dans les branches profondes du plexus cervical, notamment le nerf phrénique et le sympathique cervical. Nous allons passer maintenant à la paroi interne, qui est constituée par l'axe viscéral du cou, avec la présence de la glande thyroïde, le larynx et la trachée, le pharynx et l'œsophage, et également le nerf récurrent de chaque côté. Pour ce qui est de la paroi externe, elle est constituée par un double plan musculaire engainé par les aponeuroses cervicales moyens et superficiels.

Nous avons d'une façon superficielle les muscles sternocleidomastoidiens engainés par l'aponeurose cervical superficiel, et plus profondément, nous avons en arrière le ventre postérieur du muscle homosternomastoïdien, dont le tendon couvre l'axe vasculaire du cou, et en avant, nous avons le muscle sternocleidomastoidien, engainé tous les deux par l'aponeurose cervical moyen. Nous allons parler maintenant du muscle sternocleidomastoidien. Il présente à décrire trois vaisseaux et deux couches, une profonde et une superficielle.

La couche profonde, appelée muscle clédomastoïdien, s'étend de la clavicule à la mastoïde. Pour ce qui est de la couche superficielle, elle est constituée par le muscle sternomastoïdien en avant, qui s'étend du manubrium sternal à la mastoïde, et le muscle clédo-occipital en arrière, qui s'étend de la clavicule à l'os occipital. La couche profonde est totalement couverte par la couche superficielle, et le muscle sternocleidomastoidien est contenu dans un dédoublement de

l'aponeur cervical superficiel.

Le muscle sternocleidomastoidien est vascularisé essentiellement par les branches de l'artère carotidexterne. Il est innervé sur le plan moteur par le nerf accessoire et sur le plan sensitif par le plexus cervical profond. Pour ce qui est de ses actions, si le point fixe est en bas, il va fléchir la tête et l'incliner de son côté.

La contraction des deux sternocleidomastoidiennes fléchit la tête en avant ou bien en arrière, selon la position initiale de la tête. Si le point fixe est en haut, le muscle sera un muscle inspiratoire accessoire. Nous allons parler maintenant du contenu de la gouttière carotidienne.

Il est constitué par l'artère carotide primitive et ses branches de division, la veigulaire interne, le nerf pneumogastrique et le nerf hypogloss. Nous allons parler maintenant de l'artère carotide primitive. Sur cette vue postérieure de la gouttière carotidienne, nous voyons ici la naissance à droite de la bifurcation du tronc brachiocéphalique et à gauche la naissance de la carotide primitive de la crosse de la rote.

Faites attention, c'est une vue qui est postérieure, alors la droite est là. L'artère carotide primitive se termine au niveau du bord supérieur du cartilage séruide en avant et de C4 en arrière. La bifurcation carotidienne se fait en dehors du pharax, entre les muscles digastriques en haut et homo-ihydiens en bas.

Cette bifurcation présente à décrire le corpus cul carotidien d'Arlande qui est une glande nerveuse qui joue un rôle important dans la régulation de la tension artérielle. Alors, nous allons passer aux branches de division qui sont la carotide externe qui se dirige en haut et en dehors avant de pénétrer dans la région parotidienne et la carotide interne qui se dirige en haut et en dedans et pénètre dans l'espace sous-parotidien postérieur. Les deux vaisseaux n'appartiennent à la région que dans leur portion au-dessous du muscle digastrique.

Nous allons parler maintenant de la veine jugulaire interne qui est la veine profonde principale du cou. Elle fait suite en sinus latéral par le trou digéré postérieur. Elle longe la face externe de la carotide primitive et se termine au niveau de la base du cou en s'unissant à la veine sous-clavière au niveau du conflit en veneur de Pirogov tout par le tronc veneur brachiocéphalique.

Elle présente comme collatéral le tronc veneur thyrolingo-facial thyroïde linguae faciale et la veine thyroïdienne moyenne qui joue un rôle dans la vascularisation de la glande thyroïde. Après la carotide primitive, la veine jugulaire interne, nous parlons maintenant d'une herbe homogastrique ou bien visièrè crânienne qui traverse la région avant d'atteindre le thorax et chemine dans l'angle dièrè jugulocarotidien au vert en arrière. Pour ce qui est d'une herbe hypoglosse, elle ne fait partie de la région que dans la partie supérieure.

Elle est oblique en bas en avant. Elle donne sa branche descendante qui chemine sur la face externe de la veine jugulaire interne et qui va énerver les muscles sous-fluidiens. Faisant partie

également de la gouttière carotidienne, nous avons la chaîne lymphatique jugulaire constituée par 20 à 30 ganglions entre la veine jugulaire interne et les muscles sternocléoïdiens de la soulienne qui drainent la face, la nuque et les voies aérodigestives supérieures.

Une tumeur maligne du larynx, par exemple, peut s'accompagner d'adénopathie cervicale de la région jugulocarotidienne. Ce drainage se termine à la base du cou au niveau de la grande veine lymphatique à droite et du canal thoracique à gauche. Nous allons parler maintenant des rapports qui se font en arrière avec la région prévertébrale avec le plexus cervical et sympathique cervical et l'artère et veine vertébrale.

En dedans, ils se font avec l'axe aérodigestif du cou avec le pharynx et le larynx, la trachée et l'œsophage, l'œsophage ici, la trachée, le nerf laryngé supérieur et le récurrent. Les rapports se font en avant au-dessus de l'océide avec les muscles sous-hyidiens et la glande thyroïde. Au-dessus de l'océide, ils se font avec la région sous-hyidienne et la glande submandibulaire.

En haut, ils se font en avant avec la région parotidienne et en arrière avec l'espace sous-parotidien postérieur. En bas, ils se font avec le médiastin en dedans et en dehors avec la région sus-claviculaire.